

통 보 사 항

1. 제 목 : 완화의료 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : \$\$병원

3. 내 용 : \$\$병원에서는 회복 가능성이 희박한 말기 환자들의 통증완화와 정신적 안정 등을 통하여 삶의 질을 유지하면서 임종을 맞을 수 있도록 완화의료 20병상을 운영하고 있습니다.

완화의료 건강보험 요양급여 비용은 입원일당 정액수가(입원료 + 행위료 + 약·치료재료 비용 + 완화의료 보조활동비)와 인력확보 수준(간호사, 사회복지사)에 따라 등급을 구분하여 입원료를 가산하는 인력 가산제를 기본으로 하고 있으며, 혈액암 환자에게 투여하는 수혈, 기존 투석치료, 마약성 진통제, 전인적 돌봄 상담료, 임종관리료 등은 급여를 별도로 산정할 수 있는 목록으로 시행하고 있습니다.

이중 임종 관리료는 임종이 임박한 환자와 그 가족이 편안한 임종을 맞이하도록 의사 30분, 간호사 60분, 사회복지사 30분 이상 임종관련 신체적·심리적·사회적 돌봄과 지지를 제공하는 경우 산정하도록 되어 있습니다.

그러므로 가능한 임종을 맞이하는 대상자들에게는 삶의 질을 유지하면서 임종을 맞을 수 있도록 임종관리 서비스를 제공하여야 합니다.

그런데 '16년 \$\$병원 완화의료 서비스 대상자 중 상담시간 부족 등의 사유로 임종관리료를 청구하지 못한 경우가 [표 1]과 같이 17건 상당인 것으로 확인되었습니다.

또한, 완화의료 병상 가동률은 [표 2]와 같이 '16.3분기 기준 98%를 초과하고 있어 거의 공실이 없는 상태로 운영되고 있는데, 간호 인력은 10명(사고 발생 시 10명 미만)이하를 배치하고 있어 입원료 가산 3등급을 적용받고 있습니다.

[표 1] 임종관리 미충족 현황

순번	등록번호	성명	순번	등록번호	성명
1	*****24	^^^	10	*****18	^^^
2	*****16	^^^	11	*****41	^^^
3	*****88	^^^	12	*****84	^^^
4	*****44	^^^	13	*****61	^^^
5	*****19	^^^	14	*****01	^^^
6	*****18	^^^	15	*****81	^^^
7	*****43	^^^	16	*****00	^^^
8	*****38	^^^	17	*****21	^^^
9	*****72	^^^			

[표 2] 완화의료 병상 가동률

구분	평균	'16.3분기	'16.2분기	'16.1분기	'15.4분기
병상 가동률(%)	97.11	98.20	98.55	98.75	95.95

그런데 '16.3분기를 기준할 때 입원료 가산 등급을 1등급 상향(3등급→2등급) 하기 위해서는 간호인력 3명이 추가 소요되며, 이 경우 수입은 26백만 원 상당이 증가 하지만 인건비는 30백만 원 상당이 추가 소요될 것으로 추정됩니다.

[표 3] 간호등급 상향시 수입추정

(단위 : 명, 백만 원)

구분	간호인력	수입(추정)	인건비	비고
간호 3등급	10	708	165	현재 적용
간호 2등급	13	734	195	검토안
증 감	3	26	30	

4. 조치할 사항

○ \$\$병원장은

- 완화의료 서비스 대상자 중 상담시간 부족 등의 사유로 임종관리료를 청구하지 못하는 경우가 발생하지 않도록 관리하여 주시고(통보)
- 완화의료 병상 가동률(98% 상당), 대외 공신력, 운영 효율성 등을 고려하여 간호인력 목표 등급을 명확하게 한 후 완화의료 간호 인력을 배치하여 주시기 바랍니다.(통보)